



Tranquilização

Tranquilização é o uso de medicação para ajudar a pessoa a se acalmar, reduzir a angústia, a agitação ou o sofrimento intenso durante uma crise. A ideia não é “apagar” a pessoa, mas diminuir a intensidade da crise para que o cuidado possa continuar. A via oral – comprimido, cápsula ou líquido – é sempre a primeira escolha quando possível, porque é menos invasiva e permite que a própria pessoa participe do cuidado, aceitando tomar o medicamento. Já a via parenteral, feita por injeção, tem efeito mais rápido e pode ser necessária quando a crise é muito intensa ou quando a via oral não é viável, mas exige maior cautela ética por ser mais invasiva. Em ambos os casos, o que define o cuidado não é a via utilizada, e sim o consentimento, a finalidade terapêutica e o uso da medicação para aliviar sofrimento – e não para silenciar ou controlar a pessoa.

O que estamos medicando? Tranquilização, quando ofertada como apoio para reduzir sofrimento e permitir que a pessoa recupere capacidade de escolha, pode ser parte de um cuidado orientado por direitos e por evidências. A própria ideia de “tranquilizar” precisa ser resgatada do campo do castigo e recolocada no campo do suporte.

Vamos analisar a tranquilização sob o mesmo critério da avaliação: clareza, respeito, consentimento, monitoramento e registro. A oferta precisa ser explicada em linguagem simples: o que é, por que se sugere, quais efeitos se esperam, quais cuidados de segurança serão feitos, qual será a reavaliação. E precisa ser oferta real, não ultimato. Em crise, a pessoa percebe rapidamente quando a “oferta” carrega ameaça. O modo de ofertar é parte do efeito e parte do vínculo.

A tranquilização deve vir preferencialmente após um conjunto de mediações anteriores: ambiência, comunicação, presença, pactos curtos. Quando o serviço pula essas etapas e vai direto ao medicamento, ele comunica que não há espaço para a palavra. Para pessoas com histórico de coerção, isso tende a aumentar a resistência e agitação. A tranquilização é parte do cuidado de desescalada, o objetivo é baixar intensidade para que o diálogo volte a ser possível, o que não significa “resolver” a crise por silenciamento, e não um fim.

Há também a dimensão clínica e de segurança. Em crises, podem existir fatores físicos relevantes: privação de sono severa, intoxicação, abstinência, dor, desidratação, condições clínicas associadas. O cuidado orientado por direitos, como lembram mhGAP e diretrizes de boas práticas da OMS, não reduz o corpo ao “psíquico”. A avaliação breve precisa manter atenção a sinais clínicos importantes e encaminhar quando necessário. Tranquilização não pode encobrir urgências clínicas; precisa ser parte de um plano de cuidado que inclua observação, reavaliação e, quando indicado, suporte clínico mais amplo.



Tranquilização voluntária se relaciona com confiança. Em serviços nos quais a hospitalidade é consistente, o usuário pode aceitar apoio medicamentoso como parte de um pacto e pode também se sentir seguro em não aceitar, sendo respeitado em sua decisão sem retaliações do serviço. Lembre-se que a negociação em momentos de crise é constante e toda decisão pode ser revista, portanto não há desespero se o usuário não aceita a medicação, ainda mais quando ele o faz sentindo a segurança da continência do serviço. Em serviços nos quais a hostilidade domina, o mesmo apoio vira ameaça. Essa diferença é fundamental: o serviço precisa construir uma reputação de cuidado não punitivo para que a oferta seja escutada como cuidado. Isso implica regras simples: explicar, negociar, registrar e reavaliar.

Desse modo, tranquilização precisa ser revisada no pós-crise. Devemos ter um processo que justifique se foi necessária, a equipe deve perguntar: o que faltou antes? Como ampliar mediações para reduzir necessidade futura? Que sinais precoces podem ser reconhecidos? Que planos colaborativos podem ser feitos para que a pessoa tenha estratégias próprias de regulação antes do pico? A tranquilização, o famoso uso do “se necessário”, não deve se tornar hábito. Ela deve ser exceção dentro de um cuidado que prioriza autonomia e rede. Quando se transforma em hábito, ela tende a substituir o trabalho mais difícil, a essência do cuidado, o trabalho de vínculo e, com isso, enfraquece o serviço.

Uma política de PRN (se necessário) bem construída pode ajudar a evitar improvisos e abusos. “Bem construída” significa: critérios claros, registro obrigatório de indicação e resposta, reavaliação em tempo definido e, sobretudo, participação do usuário na elaboração do plano quando não está em crise. A pessoa pode dizer o que tolera, o que teme, o que já funcionou e o que piora. Isso transforma a medicação de instrumento de poder em instrumento de cuidado pactuado.

É fundamental insistir em voluntariedade e em revisão pós-crise: se a medicação é ponte, ela precisa levar a um plano, não a uma rotina de silenciamento.